

Depuis deux ans, un homme de 75 ans présente une fibrillation auriculaire avec une fréquence ventriculaire moyenne de 72/min. Il ne se plaint ni d'oppression thoracique ni d'essoufflement et il n'a pas d'oedèmes malléolaires. Sa tension artérielle est normale et il ne prend aucun médicament.

Quelle mesure thérapeutique est la plus indiquée?

- (A) un bêtabloquant
- (B) un dérivé de la coumarine
- (C) la digoxin
- (D) l'agrégation plaquettaire avec de l'Aspirine®
- (E) l'électrocardioversion

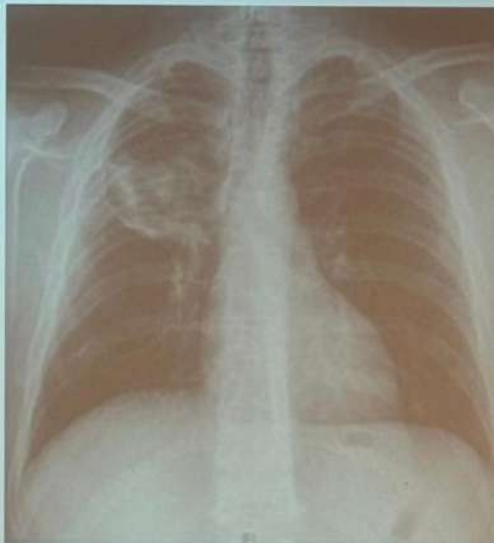
Quel est le traitement initial le plus approprié chez ce patient?

- (A) Isoniazide
- (B) Isoniazide, pyrazinamide et éthambutol
- (C) Isoniazide, pyrazinamide, éthambutol et rifampicine
- (D) Isoniazide, pyrazinamide, rifampicine et zidovudine
- (E) Acide para-aminosalicylique, cycloserine et éthionamide

Homme 42 ans, fièvre, sudations nocturnes, perte pondérale, toux depuis 1 mois.

Incarcéré brièvement il y a 10 mois en raison d'usage de drogues. A cette époque, Quantiferon et test HIV nég.

Examen directe expecto: nombreux BAAR.
Expectorations envoyées pour culture



Lors d'un examen d'entourage d'une famille effectué après découverte d'un cas de tbc, un enfant de 7 ans a un quantiféron positif. N'a pas eu de BCG.

La Rx thorax est normale

Mesure la plus appropriée?

- (A) Entreprendre un traitement à base d'isoniazide (INH)
- (B) Donner une triples association antitbc (INH, ethambutol, rifampicine)
- (C) Vacciner par le BCG
- (D) Faire une Rx contrôle dans 6 semaines
- (E) Ne rien faire

Homme de 45 ans, transplanté rénal depuis 2 ans. Depuis lors, suivi par quantiferon 1x/an. Jusqu'alors, quantiferon était négatif.

Le quantiferon actuel est positif.

La Rx thorax est normale

Que faire?

- (A) Pas de ttt, répéter le Mantoux dans 6 semaines
- (B) Pas de ttt, répéter régulièrement les Rx thorax
- (C) Débuter un ttt pour une tuberculose latente
- (D) Débuter une quadrithérapie anti-tbc
- (E) Diminuer le régime immunosuppresseur

Chez un patient de 60 ans avec une méningite lymphocytaire (300 cellules mononuclées dans le LCR), on note après 4 jours d'observation l'apparition d'une diplopie. Vous mettez en évidence une parésie du muscle abducteur droit.

Quel est le microorganisme le plus vraisemblable?

- A. *Borrelia burgdorferi*
- B. *Treponema pallidum*
- C. *Mycobacterium tuberculosis*
- D. *Coxiella burnetii*
- E. *Brucella abortus*

Un patient de 74 ans présente brusquement des céphalées, des vomissements et des frissons.

Lors de l'entrée à l'hôpital, il est somnolent, flasque, fébrile à 40.5 °C. La respiration est profonde, lente et râlante.

La tension artérielle est de 140/80 mmHg, le pouls est régulier, sa fréquence est de 98/min.

Quel sera l'examen le plus urgent à pratiquer, déterminant pour le diagnostic?

- A. une formule sanguine complète
- B. des hémocultures
- C. un examen complet des urines
- D. une radiographie thoracique
- E. une ponction lombaire

Chez un jeune homme de 19 ans, un syndrome néphrotique apparaît. Son médecin commence un traitement par des glucocorticostéroïdes. Les oedèmes diminuent et le poids baisse. Subitement, le malade ressent des douleurs intenses dans la loge rénale droite et sous le rebord costal droit, latéralement.

Il doit rester assis et il ne peut plus se coucher sur le dos, tant ses douleurs sont intenses. L'examen des urines révèle une forte protéinurie.

A quel diagnostic pensez-vous en premier?

- A. une crise de lithiase rénale
- B. une cholécystite aiguë
- C. une thrombose de la veine rénale
- D. une appendicite aiguë
- E. une embolie pulmonaire

Quelle affection n'est pas une cause d'un syndrome néphrotique?

- A. la glomérulonéphrite membranaire
- B. le lupus érythémateux disséminé
- C. l'amyloïdose
- D. le diabète (sucré)
- E. la pyélonéphrite

Un homme de 24 ans, toxicomane par voie intraveineuse connu, se plaint d'un état subfébrile, d'inappétence progressive et de dorsalgies depuis 5 jours. A l'hospitalisation, le patient est en état général diminué, mais bien orienté. Il souffre de céphalées, mais ne présente pas de méningisme. Sa température est à 38.8°C, sa tension artérielle à 95/60 mmHg et son pouls à 98/min. L'examen neurologique est normal, sauf une hypoesthésie au bord latéral du pied gauche. La percussion de la colonne vertébrale lombaire est douloureuse.

Valeurs de laboratoire:

leucocytes	16 G/l (norme: 4.5-11)
hémoglobine	6.4 mmol/l (norme: 8.4-10.9)
thrombocytes	426 G/l (norme: 150-350)

Quelle investigation permettra de poser le diagnostic?

- (A) une IRM de la colonne lombaire
- (B) une radiologie conventionnelle de la colonne lombaire
- (C) la recherche des facteurs rhumatoïdes
- (D) une ponction lombaire
- (E) aucune des investigations susmentionnées